

Les premières cellules apparaissent aux environs du 18ème jour. Les cellules sanguines, trois parties importantes. L'origine va venir de la vésicule ombilicale, qui vient s'intégrer par rapport au sang. C'est là où est ce qu'on appelle les mégalo blasts primitifs. Ça dure les deux premiers mois. Début du premier mois, un deuxième mouvement qui vient du foie. Le sang va se développer à partir du foie. Et c'est seulement aux alentours du troisième mois qu'il y a une partie qui commence à se faire au niveau de la moelle osseuse. Donc on pourrait dire qu'on se développe de nouveau de la périphérie vers le centre. Période ombilico-pédiculaire, période hépatique. Et ici, ce sera une période, on pourrait dire, au niveau des globules rouges. Le seul vestige qui va rester de ce développement vitellin sera l'artère mésentérique. Ça servait d'axe de rotation, un fulcrum pour la rotation du développement de l'anse intestinale. Au moment où j'ai ma cavité amniotique, qui fait ça, tout autour. Au même moment, j'ai ma vésicule vitelline qui est là, qui contient les cellules originelles pour la circulation. Et se réintègre. Pour une partie, avec la vésicule vitelline, le pédicule embryonnaire forme le colon ombilical avec le placenta. Et le vestige qui va se relier, c'est le système mésentérique. C'est la vésicule supérieure. Axe de rotation très importante pour le développement embryonnaire. Quand on regarde le cœur, vous avez la crosse de la horte. Symboliquement, on peut dire qui monte ou qui descend. Votre main droite, comme ça. Ceci représente le mouvement du cœur. Dans son battement. Qui répète, lui, presque un mouvement développemental. La crosse de la horte, c'est quelque chose qui fait dans le mouvement du cœur un mouvement de torsade ou de détorsade. Au moment où le cœur va pousser, la crosse de la horte s'ouvre pour absorber le sang. Le moment où ça descend, ça se vide en faisant un mouvement comme ça. Donc au moment où ça fait comme ceci, la crosse de la horte s'ouvre pour prendre le sang et se ferme pour l'éjecter. Donc on doit relier la crosse de la horte au cœur

dans la fonction. Alors c'est un peu comme les gens qui font du basket. Au moment où je monte, c'est là où la horte éjecte son volume. Vous savez que la horte contient dans sa volémie presque autant de sang qu'il y a le cœur. Sur le plan artériel, tu vois. Donc ça veut dire que la horte participe à l'éjection systolique. Mais n'oubliez pas que c'est soutenu par l'environnement facial. Par le fishnet stocking. Vous avez la crosse de la horte. Vous avez la bifurcation bronchique. Vous avez la bifurcation bronchique. Et vous avez encore une autre partie qui est l'œsophage, qui sont reliés par ce fascia commun, qui sont maintenus ensemble. Vous avez la bifurcation bronchique. Vous avez la bifurcation bronchique. Vous avez la bifurcation bronchique. Vous avez la bifurcation bronchique. Vous avez la bifurcation bronchique. C'est ce qu'on appelle le point de la zone rythmique. Vous avez la bifurcation bronchique. 100 000 battements cardiaques en 24 heures, 23 000 respirations en 24 heures, 1 000 à 2 000 déglutitions. Vous avez la bifurcation bronchique. Vous avez la bifurcation bronchique. C'est une grande zone rythmique qui vient tous se joindre et s'attacher entre D3, D4 et D5, qui sont un plan d'équilibre sur un plan facial de la zone rythmique, cardio, pleuro, digestif. J'ai la horte ici, j'ai le cœur qu'il y a ici, et en bas il va y avoir une bifurcation très importante ici, qu'on appelle les artères iliaques. Et ici en haut, je vais avoir encore un autre niveau. Mais en fait, ceci forme un plan, on va dire, unitaire, pur. On voit que dans certaines pathologies de type coxo-fémoral ou n'importe quoi, ça peut déstabiliser le cœur. Et inversement, ce qui se passe ici, dans les phases de rotation ici, peuvent se manifester jusqu'au niveau du cœur.